

Le critère D précise que le comportement stéréotypé, répétitif dans les mouvements stéréotypés n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à un trouble neurologique et n'est pas mieux expliqué par un autre trouble mental ou neurodéveloppemental. La présence de mouvements stéréotypés peut indiquer un problème neurodéveloppemental non détecté, tout particulièrement chez des enfants âgés de 1 à 3 ans.

Prévalence

Les mouvements stéréotypés simples (p. ex. balancement) sont fréquents chez les jeunes enfants se développant normalement. Les mouvements stéréotypés complexes sont bien moins fréquents (survenant chez environ 3-4 % des personnes). Entre 4 et 16 % des individus ayant un handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel) se livrent à des stéréotypies et des automutilations (Arron et al. 2011 ; Harris 2010). Le risque est plus important chez les personnes ayant un handicap intellectuel grave. Parmi les individus avec un handicap intellectuel vivant dans des structures résidentielles, 10-15 % peuvent avoir des mouvements stéréotypés avec comportements d'automutilation (Harris 2010).

Développement et évolution

Les mouvements stéréotypés débutent typiquement au cours des 3 premières années de la vie. Les mouvements stéréotypés simples sont fréquents dans la petite enfance et peuvent être impliqués dans l'acquisition de la maîtrise de la motricité. Chez les enfants qui développent des stéréotypies motrices complexes, environ 80 % présentent des symptômes avant l'âge de 24 mois, 12 % entre 24 et 35 mois, et 8 % à 36 mois ou plus (Harris et al. 2008). Chez la plupart des enfants se développant normalement, ces mouvements se résolvent avec le temps ou peuvent être supprimés. Le début des stéréotypies motrices complexes peut être dans la petite enfance ou plus tard dans la période développementale. Parmi les individus ayant un handicap intellectuel, les comportements stéréotypés, automutilatoires peuvent persister pendant des années, même si la topographie ou le schéma des automutilations peuvent changer (Arron et al. 2011 ; Berkson et al. 2001 ; Harris 2010 ; Oliver et al. 2012).

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. L'isolement social est un facteur de risque de progression d'autos-timulations vers des mouvements stéréotypés avec des automutilations répétées. Le stress environnemental peut aussi déclencher un comportement stéréotypé. La peur peut altérer l'état physiologique, entraînant une plus grande fréquence de comportements stéréotypés.

Génétiques et physiologiques. Un fonctionnement cognitif faible est lié à un plus grand risque de comportements stéréotypés et à une réponse plus mauvaise aux interventions. Les mouvements stéréotypés sont plus fréquents parmi les individus avec un handicap intellectuel moyen à grave/profond qui, à cause d'un syndrome spécifique (p. ex. le syndrome de Rett) ou d'un facteur environnemental (p. ex. un environnement avec un niveau de stimulation relativement insuffisant) semblent être plus à risque de développer des stéréotypies. Un comportement automutilatoire répétitif peut être un phénotype comportemental dans les syndromes neurogénétiques (Harris 2010). Par exemple, dans le syndrome de Lesch-Nyhan, il y a à la fois des mouvements dystoniques stéréotypés et des automutilations des doigts, des mordillements des lèvres et d'autres formes d'automutilations à moins que le sujet ne soit contenu (Harris 2010 ; Oliver et al. 2012), et dans le syndrome de Rett et le syndrome de Cornelia de Lange, les automutilations peuvent résulter des stéréotypies mains-bouche (Oliver et al. 2012). Les

comportements stéréotypés peuvent résulter d'une affection médicale douloureuse (p. ex. infection de l'oreille moyenne, problèmes dentaires, reflux gastro-œsophagien) (Courtemanche et al. 2012 ; de Winter et al. 2011).

Questions diagnostiques liées à la culture

Les mouvements stéréotypés, avec ou sans comportements d'automutilations, surviennent quelles que soient l'origine ethnique et la culture. Les attitudes culturelles à l'égard des comportements inhabituels peuvent entraîner un retard diagnostique. De manière générale, les attitudes et la tolérance culturelles à l'égard des mouvements stéréotypés varient et doivent être prises en considération.

Diagnostic différentiel

Développement normal. Les mouvements stéréotypés simples sont fréquents dans la petite enfance et au début de l'enfance. Les balancements peuvent survenir lors de la transition sommeil-éveil, un comportement qui se résout avec l'âge. Les mouvements stéréotypés complexes sont moins fréquents chez les enfants se développant normalement et ils peuvent habituellement être supprimés par les distractions et les stimulations sensorielles. La routine quotidienne du sujet est rarement perturbée, et les mouvements n'entraînent généralement pas de détresse chez l'enfant. Le diagnostic ne serait pas approprié dans ces circonstances.

Trouble du spectre de l'autisme. Les mouvements stéréotypés peuvent être un symptôme de présentation du trouble du spectre de l'autisme et ce trouble doit être évoqué quand des comportements et des mouvements répétitifs font l'objet d'une évaluation. Des déficits de la communication et de la réciprocité sociale qui se manifestent dans le trouble du spectre de l'autisme sont généralement absents dans les mouvements stéréotypés, et par conséquent les interactions sociales, la communication sociale et les intérêts et comportements rigides et répétitifs sont des caractéristiques distinctives. Quand un trouble du spectre de l'autisme est présent, les mouvements stéréotypés ne sont diagnostiqués que lorsqu'il y a automutilation (Richards et al. 2012 ; Sterling et al. 2011) ou quand les mouvements stéréotypés sont suffisamment graves pour devenir une cible du traitement.

Tics. Typiquement, les stéréotypies ont un âge de début plus précoce (avant 3 ans) que les tics, qui ont un âge de début moyen de 5-7 ans. Elles sont constantes et fixes dans leur schéma ou leur topographie alors que les tics sont variables dans leur présentation. Les stéréotypies peuvent impliquer les bras, les mains ou le corps entier, tandis que les tics impliquent les yeux, le visage, la tête et les épaules. Les stéréotypies sont plus fixes, rythmiques et prolongées en durée que les tics qui, généralement, sont brefs, rapides, aléatoires et fluctuants. Les tics et les mouvements stéréotypés sont tous deux réduits par les distractions.

Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés. Les mouvements stéréotypés se distinguent du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) par l'absence d'obsessions, ainsi que par le type de comportements répétitifs. Dans le TOC le sujet se sent poussé à exécuter des comportements répétitifs en réponse à une obsession ou selon des règles qui doivent être appliquées de manière rigide, alors que dans les mouvements stéréotypés le sujet est apparemment contraint d'exécuter les comportements qui sont en apparence sans but. La trichotillomanie (arrachage compulsif de ses propres cheveux) et la dermatillomanie sont des troubles caractérisés par des comportements répétitifs centrés sur le corps (c.-à-d. arrachage compulsif de ses propres cheveux et trituration de la peau) que le sujet est apparemment contraint d'exécuter mais qui ne sont pas apparemment sans but, et qui ne suivent pas un schéma ou un rythme. D'autre part,

le début dans la trichotillomanie et l'excoriation n'est pas typiquement dans la période développementale précoce mais plutôt autour de la puberté ou plus tard.

Autres affections neurologiques et médicales. Le diagnostic des mouvements stéréotypés nécessite d'exclure les habitudes, les maniérismes, les dyskinésies paroxysmiques et la chorée héréditaire bénigne. Une anamnèse et un examen neurologique sont nécessaires pour évaluer les caractéristiques évocatrices d'autres troubles tels que la myoclonie, la dystonie, les tics et la chorée. Les mouvements involontaires associés à une affection neurologique peuvent être distingués par leurs signes et symptômes. Par exemple, les mouvements stéréotypés et répétitifs des dyskinésies tardives peuvent être distingués par l'existence d'antécédents d'utilisation chronique de neuroleptiques et une dyskinésie orale ou faciale caractéristique ou des mouvements irréguliers du tronc ou des membres. Ce type de mouvements n'entraîne pas d'automutilations. Un diagnostic de mouvement stéréotypé n'est pas approprié pour les grattages ou triturations de peau répétitifs associés aux intoxications ou abus d'amphétamines (p. ex. les patients ont un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif ou apparenté induit par une substance/un médicament) ni pour les mouvements choréo-athétosiques répétitifs associés à d'autres troubles neurologiques.

Comorbidité

Les mouvements stéréotypés peuvent survenir comme un diagnostic primaire ou secondaire à un autre trouble (Singer 2011). Par exemple, les stéréotypies sont une manifestation fréquente d'une variété de troubles neurogénétiques tels que le syndrome de Lesch-Nyhan, le syndrome de Rett, le syndrome de l'X fragile, le syndrome de Cornelia de Lange et le syndrome de Smith-Magenis (Oliver et al. 2012). Quand les mouvements stéréotypés coexistent avec une autre affection médicale, les deux diagnostics doivent être enregistrés.

Tics

Critères diagnostiques

N.B. : Un tic est un mouvement – ou une vocalisation – soudain, rapide, récurrent et non rythmique.

Syndrome de Gilles de la Tourette

307.23 (F95.2)

- A. Présence de tics moteurs multiples et d'un ou de plusieurs tics vocaux, à un moment quelconque au cours de l'évolution de la maladie mais pas nécessairement de façon simultanée.
- B. La fréquence des tics peut croître et décroître mais ils persistent depuis plus d'une année après leur première apparition.
- C. Le début est avant l'âge de 18 ans.
- D. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. cocaïne) ou à une autre affection médicale (p. ex. maladie de Huntington, encéphalite virale).

Tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques)

307.22 (F95.1)

- A. Présence soit de tics moteurs soit de tics vocaux, uniques ou multiples, au cours de la maladie, mais pas à la fois moteurs et vocaux.
- B. La fréquence des tics peut croître et décroître mais ils persistent depuis plus d'une année après leur première apparition.

- C. Le début est avant l'âge de 18 ans.
- D. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. cocaïne) ou à une autre affection médicale (p. ex. maladie de Huntington, encéphalite virale).
- E. Les critères du Syndrome de Gilles de la Tourette n'ont jamais été remplis.

Spécifier si :

Avec tics moteurs exclusivement

Avec tics vocaux exclusivement

Tics provisoires

307.21 (F95.0)

- A. Tics moteurs et/ou vocaux uniques ou multiples.
- B. Les tics sont présents depuis moins d'une année après leur première apparition.
- C. Le début est avant l'âge de 18 ans.
- D. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. cocaïne) ou à une autre affection médicale (p. ex. maladie de Huntington, encéphalite virale).
- E. Les critères du syndrome de Gilles de la Tourette n'ont jamais été remplis, ni ceux des tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques).

Spécifications

La spécification « tics moteurs exclusivement » ou « tics vocaux exclusivement » n'est requise que pour les tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques).

Caractéristiques diagnostiques

Les tics comprennent quatre catégories diagnostiques : le syndrome de Gilles de la Tourette, les tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques), les tics provisoires, les autres tics spécifiés, et les tics non spécifiés. Le diagnostic pour tous les troubles qualifiés de tics est fondé sur la présence de tics moteurs et/ou vocaux (critère A), la durée des tics symptomatiques (critère B), l'âge de début (critère C) et l'absence de toute cause connue telle qu'une autre affection médicale ou un usage de substance (critère D). Les tics sont classés dans un ordre hiérarchique (c.-à-d. syndrome de Gilles de la Tourette, suivi des tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques), suivi des tics provisoires, suivi des autres tics spécifiés et des tics non spécifiés), de telle sorte qu'une fois qu'un tic est diagnostiqué à un niveau de la hiérarchie, un diagnostic à un niveau hiérarchique moindre ne peut être fait (critère E).

Les tics sont des mouvements moteurs ou des vocalisations soudains, rapides, récurrents et non rythmiques. Une personne peut avoir des symptômes tics variables dans le temps mais, à un moment donné, le répertoire des tics se répète d'une manière caractéristique. Même si les tics peuvent inclure presque tous les groupes musculaires ou toutes les vocalisations, certains tics, tels que le clignement des yeux ou le raclement de gorge, sont fréquents dans toutes les populations de patients. Les tics sont généralement subis de manière involontaire mais ils peuvent être volontairement supprimés pour des durées variables (Bloch et al. 2011 ; Singer 2011).

Les tics peuvent être soit simples soit complexes. *Les tics moteurs simples* sont de courte durée (c.-à-d. des millisecondes) et peuvent inclure des clignements des yeux, des haussements d'épaules et l'extension des extrémités. Les tics vocaux simples incluent le raclement de gorge, le reniflement et le grognement souvent généré par la contraction du diaphragme ou des muscles de l'oropharynx. *Les tics moteurs complexes* sont de durée plus longue (c.-à-d. des secondes) et incluent souvent une combinaison de

tics simples tels que le fait de tourner la tête et de hausser les épaules simultanément. Les tics complexes peuvent sembler avoir un but, tels que des gestes sexuels ou obscènes s'apparentant à des tics (*copropraxie*) ou l'imitation des mouvements de quelqu'un d'autre s'apparentant à des tics (*échopraxie*). De manière similaire, les tics vocaux complexes incluent la répétition de ses propres sons ou mots (*palilalie*), la répétition du dernier mot ou de la dernière phrase entendus (*écholalie*) ou l'émission de mots socialement inacceptables, dont des obscénités ou des insultes ethniques, raciales ou religieuses (*coprolalie*). Il est important de signaler que la coprolalie est l'expression soudaine et vive d'un aboiement ou d'un grognement et qu'elle n'a pas la prosodie d'autres discours, dont le contenu peut être inapproprié de façon similaire, observables dans les interactions humaines.

La présence de tics moteurs et/ou vocaux varie selon les quatre types de tics (critère A). Pour le syndrome de Gilles de la Tourette, des tics à la fois moteurs et vocaux doivent être présents, alors que pour les tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques), des tics uniquement moteurs ou des tics uniquement vocaux sont présents. Pour les tics provisoires, des tics moteurs et/ou vocaux peuvent être présents. Pour les autres tics spécifiés ou les tics non spécifiés, les symptômes des troubles du mouvement sont mieux caractérisés comme étant des tics mais ils sont atypiques dans leur présentation ou dans l'âge de début, ou ils ont une étiologie connue.

Le critère de durée de 1 an minimum (critère B) assure que les personnes ayant un diagnostic de syndrome de la Tourette ou de tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques) ont eu des symptômes persistants. La sévérité des tics croît et décroît, et certains individus peuvent avoir des périodes de plusieurs semaines ou de plusieurs mois sans tics ; cependant, une personne qui a eu des symptômes de tics d'une durée supérieure à 1 an après l'apparition des premiers tics sera considérée comme ayant des symptômes persistants indépendamment de la durée des périodes sans tics. Pour un individu avec des tics moteurs et/ou vocaux de moins de 1 an depuis le début du premier tic, un diagnostic de tics provisoires peut être considéré. Il n'y a pas de précision quant à la durée pour les autres tics spécifiés et les tics non spécifiés. Le début des tics doit survenir avant l'âge de 18 ans (critère C). Les tics débutent typiquement dans la période prépubertaire, avec un âge de début moyen entre 4 et 6 ans, l'incidence de nouveaux cas de tics diminuant pendant l'adolescence. Le début des symptômes de tics pendant l'âge adulte est extrêmement rare (Jankovic et al. 2010) et est souvent associé à l'exposition aux drogues (p. ex. usage excessif de cocaïne) ou résulte d'une agression du système nerveux central (p. ex. encéphalite post-virale). Bien que le début des tics soit inhabituel chez les adolescents et les adultes, il n'est pas rare que les adolescents et les adultes se présentent pour une évaluation diagnostique initiale et rapportent lors d'une évaluation attentive des antécédents de symptômes plus légers datant de l'enfance. De nouveaux cas de mouvements anormaux évocateurs de tics en dehors de la tranche d'âge habituelle doivent amener à l'évaluation d'autres troubles du mouvement ou d'étiologies spécifiques.

Les symptômes tics ne peuvent pas être imputables aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre affection médicale (critère D). Quand des arguments forts émanant des antécédents, de l'examen clinique et/ou des examens complémentaires suggèrent une étiologie plausible, immédiate et probable pour un tic, un diagnostic d'autres tics spécifiés doit être porté. Le fait d'avoir antérieurement répondu aux critères diagnostiques du syndrome de Gilles de la Tourette élimine un diagnostic possible de tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques) (critère E). De la même façon, un diagnostic antérieur de tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques) élimine un diagnostic de tics provisoires, ou d'autres tics spécifiés ou de tics non spécifiés (critère E).

Prévalence

Les tics sont fréquents dans l'enfance mais transitoires dans la plupart des cas. La prévalence estimée du syndrome de Gilles de la Tourette varie entre 3 et 8 pour 1 000 chez les enfants d'âge scolaire. Les hommes sont plus fréquemment touchés que les femmes, avec un ratio allant de 2/1 à 4/1 (Knight et al. 2012). Une enquête nationale aux États-Unis a estimé à 3 pour 1 000 la prévalence des cas cliniquement identifiés (Centers for Disease Control and Prevention 2009). La fréquence des cas identifiés s'est montrée plus faible parmi les Afro-Américains et les Hispano-Américains, ce qui pourrait être lié aux différences d'accès aux soins.

Développement et évolution

Les tics débutent typiquement entre l'âge de 4 et 6 ans. Le pic de sévérité survient entre les âges de 10 et 12 ans, avec une baisse de la sévérité pendant l'adolescence. De nombreux adultes souffrant de tics présentent des symptômes atténués. Un faible pourcentage d'individus aura des symptômes graves constamment ou avec une aggravation à l'âge adulte (Bloch et Leckman 2009).

Les symptômes tics se manifestent de manière similaire dans tous les groupes d'âge et au cours de la vie entière. La sévérité des tics croît et décroît et les tics changent pour ce qui est des groupes musculaires affectés et des vocalisations au cours du temps. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils commencent à signaler leurs tics comme étant associés à une pression prémonitoire – une sensation somatique qui précède le tic – et une sensation de diminution de la tension suivant l'expression du tic (Leckman et al. 1993). Les tics associés à une pression prémonitoire peuvent être vécus comme n'étant pas complètement « involontaires » car il est possible de résister à la pression et au tic. Une personne peut aussi ressentir le besoin de réaliser un tic de manière spécifique ou de le répéter jusqu'à ce qu'elle puisse avoir le sentiment que le tic a été fait « juste comme il faut ».

La vulnérabilité à développer des troubles concomitants change au fur et à mesure que les individus traversent l'âge de risque pour les divers troubles en question. Par exemple, les enfants prépubères souffrant de tics pathologiques sont plus susceptibles de présenter un déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), un trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et une anxiété de séparation que ne le sont les adolescents et les adultes, qui sont plus susceptibles de présenter le début d'un trouble dépressif caractérisé, d'un trouble de l'usage de substances ou un trouble bipolaire.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. Les tics sont aggravés par l'anxiété, l'excitation et l'épuisement et atténués pendant les périodes de calme et d'activités concentrées. Les individus peuvent avoir moins de tics quand ils sont engagés dans des devoirs ou des tâches au travail que lorsqu'ils se relaxent à la maison après l'école ou en soirée. Des événements stressants/excitants (p. ex. passer un test, participer à des activités excitantes) aggravent souvent les tics.

Environnementaux. La perception d'un geste ou d'un son chez quelqu'un d'autre peut aboutir à ce qu'une personne ayant des tics fasse le même geste ou émette un son similaire, ce qui peut être incorrectement perçu comme délibéré de la part d'autrui. Cela peut être un problème particulier quand l'individu interagit avec des figures d'autorité (p. ex. professeurs, supérieurs, police).

Génétiques et physiologiques. Des facteurs génétiques et environnementaux influencent l'expression et la sévérité des symptômes de tic. Des allèles à risque pour le syndrome de Gilles de la Tourette (O'Rourke et al. 2009) et de rares variantes géné-

tiques dans des familles avec des tics ont été identifiés (Fernandez et al. 2012 ; O’Roak et al. 2010). Des complications obstétricales, un âge paternel avancé, un poids de naissance plus bas et un tabagisme maternel actif pendant la grossesse sont associés à une sévérité plus importante des tics (Mathews et al. 2006).

Questions diagnostiques liées à la culture

Les tics pathologiques ne semblent pas varier en termes de caractéristiques cliniques, de cours évolutif ou d’étiologie en fonction de l’origine ethnique et de la culture. Cependant, l’origine ethnique et la culture peuvent affecter la manière dont les tics pathologiques sont perçus et gérés dans la famille et la communauté, et ainsi influencer les schémas de recherche d’aide et le choix du traitement (Centers for Disease Control and Prevention. 2009 ; Olfson et al. 2011).

Questions diagnostiques liées au genre

Les hommes sont plus fréquemment affectés que les femmes mais il n’existe aucune différence entre les sexes pour les types de tics, l’âge de début ou le cours évolutif. Les femmes ayant des tics pathologiques persistants sont plus susceptibles de souffrir d’anxiété et de dépression (Lewin et al. 2012).

Retentissement fonctionnel des tics

De nombreux individus avec des tics de sévérité légère à moyenne ne présentent pas de détresse ou de handicap de fonctionnement et peuvent même ne pas avoir conscience de leurs tics. Les personnes avec des symptômes plus marqués ont généralement plus de handicap dans leur vie quotidienne mais même des individus avec des tics pathologiques de sévérité moyenne voire grave peuvent bien fonctionner. La présence d’un trouble coexistant, tel que le TDAH ou le TOC, peut avoir un impact plus grand sur le fonctionnement (Hassan et Cavanna 2012). Moins fréquemment, les tics perturbent le fonctionnement dans les activités quotidiennes et entraînent un isolement social, des conflits interpersonnels, de la victimisation par les pairs, une incapacité à travailler ou à aller à l’école, et une moins bonne qualité de vie (Conelea et al. 2011a ; Conelea et al. 2011b). Les patients peuvent aussi présenter une détresse psychologique considérable. Les rares complications du syndrome de Gilles de la Tourette comprennent des blessures physiques telles que des blessures oculaires (du fait de se frapper le visage) et des blessures orthopédiques et neurologiques (p. ex. une discopathie liée à des mouvements vigoureux de la tête et du cou) (Lehman et al. 2011).

Diagnostic différentiel

Mouvements anormaux pouvant accompagner d’autres affections médicales et stéréotypies motrices. Les *stéréotypies motrices* sont définies comme des mouvements rythmiques, répétitifs, prédictibles, involontaires qui semblent réfléchis mais qui n’ont aucun but ni aucune fonction adaptative évidente et s’arrêtent lors d’une distraction (Singer 2011). Il s’agit par exemple de signes/rotations de la main, de battements du bras et de tortillements des doigts répétés. Les stéréotypies motrices peuvent être différenciées des tics grâce à l’existence, dans les stéréotypies motrices, d’un âge de début plus précoce (avant l’âge de 3 ans), d’une durée plus prolongée (de quelques secondes à plusieurs minutes), d’une forme et d’une localisation constantes répétitives et fixes, d’une exacerbation quand la personne est absorbée dans une activité, de l’absence de besoin prémonitoire et de l’arrêt lors des distractions (comme, p. ex. lorsque le sujet est appelé par son nom ou bien touché). La *chorée* est définie par des actions rapides,

aléatoires, continues, soudaines, irrégulières, imprévisibles, non stéréotypées, habituellement bilatérales et qui affectent toutes les parties du corps (c.-à-d. le visage, le tronc et les membres). Les caractéristiques temporelles, la direction et la distribution des mouvements varient d'un moment à l'autre, et les mouvements s'aggravent habituellement pendant une tentative d'action volontaire. La *dystonie* est la contraction prolongée et simultanée des muscles à la fois agonistes et antagonistes, entraînant une posture ou un mouvement déformé de parties du corps. Des postures dystoniques sont souvent déclenchées par des tentatives de mouvements volontaires et ne sont pas visibles pendant le sommeil (Sanger et al. 2010).

Dyskinésies paroxysmiques et induites par des substances. Des dyskinésies paroxysmiques se présentent habituellement comme des mouvements dystoniques ou choréo-athétosiques qui sont précipités par un mouvement volontaire ou un effort physique et moins fréquemment font suite à une activité de fond normale.

Myoclonie. La myoclonie est caractérisée par un mouvement soudain et unidirectionnel qui est souvent non rythmique. Elle peut être aggravée par le mouvement et survenir pendant le sommeil. La myoclonie se différencie des tics par sa rapidité, son absence de répressibilité et son absence d'une envie prémonitoire.

Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés. Différencier les comportements obsessionnels et compulsifs des tics peut être difficile. Les indices en faveur de comportements obsessionnels et compulsifs incluent une pulsion de type cognitif (p. ex. la peur de la contamination) et le besoin de réaliser l'action d'une certaine manière, un certain nombre de fois, de la même manière de chaque côté du corps, ou jusqu'à ce qu'un sentiment du type « juste bien » soit atteint. Les problèmes de contrôle des impulsions et les autres comportements répétitifs, dont l'arrachage compulsif de ses propres cheveux, le trituration pathologique de la peau et le mordillement des ongles persistants, semblent être plus dirigés vers un but et plus complexes que les tics (Stein et al. 2010).

Comorbidité

De nombreux troubles médicaux et psychiatriques ont été décrits comme concomitants avec les tics (O'Rourke et al. 2009), le TDAH et les troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés étant particulièrement fréquents. Les symptômes obsessionnels-compulsifs observés dans les tics tendent à être caractérisés par des symptômes de symétrie et d'ordre plus agressifs et une plus mauvaise réponse à la pharmacothérapie par des inhibiteurs de la recapture sélectifs de la sérotonine. Les enfants ayant un TDAH peuvent présenter un comportement perturbateur, une immaturité sociale et des difficultés d'apprentissage qui peuvent interférer avec la progression scolaire ou universitaire et les relations interpersonnelles et entraîner un handicap plus important que celui causé par les tics. Les individus ayant des tics pathologiques peuvent aussi avoir d'autres troubles du mouvement et d'autres troubles mentaux, tels que des troubles dépressifs, bipolaires ou liés à l'usage de substances.

Autres tics spécifiés

307.20 (F95.8)

Cette catégorie s'applique aux présentations cliniques où prédominent les symptômes caractéristiques de tics entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants mais qui ne remplissent pas tous les critères des tics ou des autres troubles de la classification diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. La catégorie autres tics spécifiés est

utilisée dans les situations où le clinicien choisit de communiquer la raison spécifique pour laquelle le tableau clinique ne remplit pas les critères des tics ni d'un autre trouble neurodéveloppemental spécifique. Cela est fait en codant « autres tics spécifiés » suivi de la raison spécifique (p. ex. « avec début après l'âge de 18 ans »).

Tics non spécifiés

307.20 (F95.9)

Cette catégorie s'applique aux présentations cliniques où prédominent les symptômes caractéristiques de tics entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants mais qui ne remplissent pas tous les critères des tics ou des autres troubles de la classification diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. La catégorie tics non spécifiés est utilisée dans les situations où le clinicien choisit de *ne pas* préciser la raison pour laquelle les critères des tics ou d'un trouble neurodéveloppemental spécifique ne sont pas remplis, et comprend aussi les tableaux cliniques où l'information est insuffisante pour faire un diagnostic plus précis.

Autres troubles neurodéveloppementaux

Autre trouble neurodéveloppemental spécifié

315.8 (F88)

Cette catégorie s'applique aux présentations cliniques où prédominent les symptômes caractéristiques d'un trouble neurodéveloppemental entraînant une altération du fonctionnement dans les domaines social, professionnel ou dans d'autres domaines importants mais qui ne remplissent pas tous les critères de l'un des troubles de la classe diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. La catégorie autre trouble neurodéveloppemental spécifié est utilisée dans les situations où le clinicien choisit de communiquer la raison précise pour laquelle la présentation clinique ne remplit les critères d'aucun trouble neurodéveloppemental spécifique. Cela se fait en codant « autre trouble neurodéveloppemental spécifié » suivi de la raison spécifique (p. ex. « trouble neurodéveloppemental associé à une exposition prénatale à l'alcool »).

L'exemple suivant est celui d'une présentation clinique qui peut être précisée en utilisant le terme « autre spécifié » :

Trouble neurodéveloppemental associé à une exposition prénatale à l'alcool : Le trouble neurodéveloppemental associé à une exposition prénatale à l'alcool est caractérisé par un ensemble de handicaps développementaux consécutifs à une exposition à l'alcool *in utero*.

Trouble neurodéveloppemental non spécifié

315.9 (F89)

Cette catégorie s'applique aux présentations cliniques où prédominent les symptômes caractéristiques d'un trouble neurodéveloppemental entraînant une altération du fonctionnement dans les domaines social, professionnel ou dans d'autres domaines importants mais qui ne remplissent pas tous les critères de l'un des troubles de la classe diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. La catégorie trouble neurodéveloppemental non spécifié est utilisée dans les situations où le clinicien choisit de *ne pas* préciser la raison pour laquelle les critères d'un trouble neurodéveloppemental spécifique ne sont pas remplis, et comprend aussi les présentations cliniques où l'information est insuffisante pour faire un diagnostic plus précis (p. ex. aux urgences).

Références

Handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel)

- Einfeld S, Emerson E: Intellectual disability, in Rutter's Child and Adolescent Psychiatry, 5th Edition. Edited by Rutter M. London, Blackwell Publishing, 2008, pp 820–840
- Evans JS: Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition. *Annu Rev Psychol* 59:255–278, 2008 18154502
- Finlayson J, Morrison J, Jackson A, et al: Injuries, falls and accidents among adults with intellectual disabilities: prospective cohort study. *J Intellect Disabil Res* 54(11):966–980, 2010 21040056 10.1111/j.1365-2788.2010.01319.x
- Gottfredson LS: Mainstream science on intelligence: an editorial with 52 signatories, history, and bibliography. *Intelligence* 24(1):13–23, 1997
- Greenspan S: Assessment and diagnosis of mental retardation in death penalty cases: introduction and overview of the special "Atkins" issue. *Appl Neuropsychol* 16(2):89–90, 2009 19430989
- Greenspan S, Granfield JM: Reconsidering the construct of mental retardation: implications of a model of social competence. *Am J Ment Retard* 96(4):442–453, 1992 1739457
- Greenspan S, Loughlin G, Black R. Credulity and gullibility in persons with mental retardation, in *International Review of Research in Mental Retardation*, Vol 24. Edited by Glidden LM. New York, Academic Press, 2001, pp 101–135.
- Greenspan S, Switzky HN, Woods GW: Intelligence involves risk-awareness and intellectual disability involves risk-unawareness: implications of a theory of common sense. *J Intellect Dev Disabil* 36(4):242–253, 2011 22050455
- Harris JC: *Intellectual Disability: Understanding Its Development, Causes, Classification, Evaluation, and Treatment*, New York, Oxford University Press, 2006
- Harris JC: Advances in understanding behavioral phenotypes in neurogenetic syndromes. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 154C(4):389–399, 2010 20981768
- Kaufmann WE, Capone GT, Carter JC, Lieberman DN: Genetic intellectual disability: neurobiological and clinical aspects, in *Capute & Accardo's Neurodevelopmental Disabilities in Infancy and Childhood*, Vol I. Edited by Accardo PJ. Baltimore, MD, Paul H Brookes, 2008, pp 155–173
- King P, Kitchner MKS: The reflective judgment model: 20 years of research about cognition, knowledge and knowing, in *Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs*. Edited by Hofer BF, Pintrich PR. Mahwah, NJ, Erlbaum, 2002, pp 17–61
- Ludi E, Ballard ED, Greenbaum R, et al: Suicide risk in youth with intellectual disabilities: the challenges of screening. *J Dev Behav Pediatr* 33(5):431–440, 2012 22668827 10.1097/DBP.0b013e3182599295
- Margolis H: *Patterns, Thinking and Cognition: A Theory of Judgment*, Chicago, IL, University of Chicago Press, 1987

- Mefford HC, Batshaw ML, Hoffman EP: Genomics, intellectual disability, and autism. *N Engl J Med* 366(8):733–743, 2012 22356326
- Michelson DJ, Shevell MI, Sherr EH, et al: Evidence report: genetic and metabolic testing on children with global developmental delay: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. *Neurology* 77(17):1629–1635, 2011 21956720
- Moss J, Howlin P: Autism spectrum disorders in genetic syndromes: implications for diagnosis, intervention and understanding the wider autism spectrum disorder population. *J Intellect Disabil Res* 53(10):852–873, 2009 19708861
- Reschly DJ: Documenting the developmental origins of mild mental retardation. *Appl Neuropsychol* 16(2):124–134, 2009 19430994 10.1080/09084280902864469
- Roeleveld N, Zielhuis GA, Gabreëls F: The prevalence of mental retardation: a critical review of recent literature. *Dev Med Child Neurol* 39(2):125–132, 1997 9062428
- Salvador-Carulla L, Bertelli M: ‘Mental retardation’ or ‘intellectual disability’: time for a conceptual change. *Psychopathology* 41(1):10–16, 2008 17952016
- Salvador-Carulla L, Reed GM, Vaez-Azizi LM, et al: Intellectual developmental disorders: towards a new name, definition and framework for “mental retardation/intellectual disability” in ICD-11. *World Psychiatry* 10(3):175–180, 2011 21991267
- Schalock RL: The evolving understanding of the construct of intellectual disability. *J Intellect Dev Disabil* 36(4):223–233, 2011 22029886
- Schalock RL, Borthwick-Duffy S, Bradley VJ, et al: *Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports*, 11th Edition, Washington, DC, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010
- Tassé MJ: Adaptive behavior assessment and the diagnosis of mental retardation in capital cases. *Appl Neuropsychol* 16(2):114–123, 2009 19430993 10.1080/09084280902864451
- Tassé MJ, Schalock RL, Balboni G, et al: The construct of adaptive behavior: its conceptualization, measurement, and use in the field of intellectual disability. *Am J Intellect Dev Disabil* 117(4):291–303, 2012 22809075
- World Health Organization: ICD-11 Content Model Draft, Version 10, April 2, 2011.
- Yalon-Chamovitz S, Greenspan S: Ability to identify, explain and solve problems in everyday tasks: preliminary validation of a direct video measure of practical intelligence. *Res Dev Disabil* 26(3):219–230, 2005 15668073

Trouble du langage

- Bishop DVM, Norbury CF: Exploring the borderlands of autistic disorder and specific language impairment: a study using standardized diagnostic instruments. *J Child Psychol Psychiatry* 43(7):917–929, 2002 12405479
- Buschmann A, Jooss B, Rupp A, et al: Children with developmental language delay at 24 months of age: results of a diagnostic work-up. *Dev Med Child Neurol* 50(3):223–229, 2008 18266869
- Clark A, O'Hare A, Watson J, et al: Severe receptive language disorder in childhood—familial aspects and long-term outcomes: results from a Scottish study. *Arch Dis Child* 92(7):614–619, 2007 17405857
- Dale PS, Price TS, Bishop DV, Plomin R: Outcomes of early language delay, I: predicting persistent and transient language difficulties at 3 and 4 years. *J Speech Lang Hear Res* 46(3):544–560, 2003 14696985
- Freed J, Adams C, Lockton E: Literacy skills in primary school-aged children with pragmatic language impairment: a comparison with children with specific language impairment. *Int J Lang Commun Disord* 46(3):334–347, 2011 21575074 10.3109/13682822.2010.500316
- King G, Fletcher P: Grammatical problems in school-age children with specific language impairment. *Clinical Linguistics and Phonetics* 7:339–352, 1993
- Law J, Rush R, Schoon I, Parsons S: Modeling developmental language difficulties from school entry into adulthood: literacy, mental health, and employment outcomes. *J Speech Lang Hear Res* 52(6):1401–1416, 2009 19951922
- Rice ML, Wexler K, Hershberger S: Tense over time: the longitudinal course of tense acquisition in children with specific language impairment. *J Speech Lang Hear Res* 41(6):1412–1431, 1998 9859895
- Rice ML, Smith SD, Gayán J: Convergent genetic linkage and associations to language, speech and reading measures in families of probands with Specific Language Impairment. *J Neurodev Disord* 1(4):264–282, 2009 19997522 10.1007/s11689-009-9031-x

- Shevell MI, Majnemer A, Webster RI, et al: Outcomes at school age of preschool children with developmental language impairment. *Pediatr Neurol* 32(4):264–269, 2005 15797183
- Shriberg LD, Tomblin JB, McSweeney JL: Prevalence of speech delay in 6-year-old children and comorbidity with language impairment. *J Speech Lang Hear Res* 42(6):1461–1481, 1999 10599627
- Tomblin JB, Zhang X, Buckwalter P, O'Brien M: The stability of primary language disorder: four years after kindergarten diagnosis. *J Speech Lang Hear Res* 46(6):1283–1296, 2003 14700355

Trouble de la phonation

- Bögels SM, Alden L, Beidel DC, et al: Social anxiety disorder: questions and answers for the DSM-V. *Depress Anxiety* 27(2):168–189, 2010 20143427
- Shriberg LD: Four new speech and prosody-voice measures for genetic research and other studies in developmental phonological disorders. *J Speech Lang Hear Res* 36(1):105–140, 1993 8450654
- Shriberg LD, Austin D, Lewis BA, et al: The speech disorders classification system (SDCS): extensions and lifespan reference data. *J Speech Lang Hear Res* 40(4):723–740, 1997 9263939
- Shriberg LD, Tomblin JB, McSweeney JL: Prevalence of speech delay in 6-year-old children and comorbidity with language impairment. *J Speech Lang Hear Res* 42(6):1461–1481, 1999 10599627

Trouble de la fluidité verbale apparaissant durant l'enfance (bégaiement)

- Howell P, Davis S: Predicting persistence of and recovery from stuttering by the teenage years based on information gathered at age 8 years. *J Dev Behav Pediatr* 32(3):196–205, 2011 21336144
- Månsson H: Childhood stuttering: incidence and development. *J Fluency Disord* 25:47–57, 2000
- Watkins RV, Johnson BW: Language abilities in young children who stutter: toward improved research and clinical applications. *Lang Speech Hear Serv Sch* 35(1):82–89, 2004 15049422
- Yairi E, Ambrose NG: Early childhood stuttering, I: persistency and recovery rates. *J Speech Lang Hear Res* 42(5):1097–1112, 1999 10515508

Trouble de la communication sociale (pragmatique)

- Bellani M, Moretti A, Perlini C, Brambilla P: Language disturbances in ADHD. *Epidemiol Psychiatr Sci* 20(4):311–315, 2011 22201208
- Bishop DVM, Norbury CF: Exploring the borderlands of autistic disorder and specific language impairment: a study using standardized diagnostic instruments. *J Child Psychol Psychiatry* 43(7):917–929, 2002 12405479
- Bishop DV, Whitehouse AJ, Watt HJ, Line EA: Autism and diagnostic substitution: evidence from a study of adults with a history of developmental language disorder. *Dev Med Child Neurol* 50(5):341–345, 2008 18384386
- Bögels SM, Alden L, Beidel DC, et al: Social anxiety disorder: questions and answers for the DSM-V. *Depress Anxiety* 27(2):168–189, 2010 20143427
- Freed J, Adams C, Lockton E: Literacy skills in primary school-aged children with pragmatic language impairment: a comparison with children with specific language impairment. *Int J Lang Commun Disord* 46(3):334–347, 2011 21575074 10.3109/13682822.2010.500316
- Ketelaars MP, Cuperus J, Jansonius K, Verhoeven L: Pragmatic language impairment and associated behavioural problems. *Int J Lang Commun Disord* 45(2):204–214, 2010 22748032 10.3109/13682820902863090
- Mackie L, Law J: Pragmatic language and the child with emotional/behavioural difficulties (EBD): a pilot study exploring the interaction between behaviour and communication disability. *Int J Lang Commun Disord* 45(4):397–410, 2010 20144007
- Piven J, Palmer P, Jacobi D, et al: Broader autism phenotype: evidence from a family history study of multiple-incidence autism families. *Am J Psychiatry* 154(2):185–190, 1997 9016266
- Rapin I, Allen DA: The semantic-pragmatic deficit disorder: classification issues. *Int J Lang Commun Disord* 33(1):82–87 ; discussion 95–108, 1998 9673220

- Reisinger LM, Cornish KM, Fombonne E: Diagnostic differentiation of autism spectrum disorders and pragmatic language impairment. *J Autism Dev Disord* 41(12):1694–1704, 2011 21416199
- Schalock RL, Borthwick-Duffy S, Bradley VJ, et al: , *Intellectual Disability: Definition, Classification: and Systems of Supports*, 11th Edition, Washington, DC, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010
- St Pourcain B, Wang K, Glessner JT, et al: Association between a high-risk autism locus on 5p14 and social communication spectrum phenotypes in the general population. *Am J Psychiatry* 167(11):1364–1372, 2010 20634369
- Whitehouse AJ, Watt HJ, Line EA, Bishop DV: Adult psychosocial outcomes of children with specific language impairment, pragmatic language impairment and autism. *Int J Lang Commun Disord* 44(4):511–528, 2009 19340628

Trouble du spectre de l'autisme

- Baird G, Charman T, Pickles A, et al: Regression, developmental trajectory and associated problems in disorders in the autism spectrum: the SNAP Study. *J Autism Dev Disord* 38(10):1827–1836, 2008 18449635
- Baird G, Douglas HR, Murphy MS: Recognising and diagnosing autism in children and young people: summary of NICE guidance. *BMJ* 343(d6360), 2011 22021468 10.1136/bmj.d6360
- Bolton PF, Carcani-Rathwell I, Hutton J, et al: Epilepsy in autism: features and correlates. *Br J Psychiatry* 198(4):289–294, 2011 21972278
- Brugha TS, McManus S, Bankart J, et al: Epidemiology of autism spectrum disorders in adults in the community in England. *Arch Gen Psychiatry* 68(5):459–465, 2011 21536975
- Geschwind DH: Genetics of autism spectrum disorders. *Trends Cogn Sci* 15(9):409–416, 2011 21855394
- Happé F, Charlton RA: Aging in autism spectrum disorders: a mini-review. *Gerontology* 58(1):70–78, 2012 21865667
- Howlin P, Goode S, Hutton J, Rutter M: Adult outcome for children with autism. *J Child Psychol Psychiatry* 45(2):212–229, 2004 14982237
- Mandell DS, Listerud J, Levy SE, Pinto-Martin JA: Race differences in the age at diagnosis among Medicaid-eligible children with autism. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 41(12):1447–1453, 2009 12447031
- Mandy W, Chilvers R, Chowdhury U, et al: Sex differences in autism spectrum disorder: evidence from a large sample of children and adolescents. *J Autism Dev Disord* 42(7):1304–1313, 2012 21947663 10.1007/s10803-011-1356-0
- Rivet TT, Matson JL: Review of gender differences in core symptomatology in autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders* 5(3):957–976, 2011
- Simonoff E, Pickles A, Charma T, et al: Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 47(8):921–929, 2008 18645422

Déficit de l'attention/hyperactivité

- Agosti V, Chen Y, Levin FR: Does Attention Deficit Hyperactivity Disorder increase the risk of suicide attempts ? *J Affect Disord* 133(3):595–599, 2011 21658780
- Barry RJ, Clarke AR, Johnstone SJ: A review of electrophysiology in attention-deficit/hyperactivity disorder, I ; qualitative and quantitative electroencephalography. *Clin Neurophysiol* 114(2):171–183, 2003 12559224
- Castellanos FX, Lee PP, Sharp W, et al: Developmental trajectories of brain volume abnormalities in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *JAMA* 288(14):1740–1748, 2002 12365958
- Cortese S, Angriman M, Maffei C, et al: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and obesity: a systematic review of the literature. *Crit Rev Food Sci Nutr* 48(6):524–537, 2008 18568858
- Frazier TW, Youngstrom EA, Glutting JJ, Watkins MW: ADHD and achievement: meta-analysis of the child, adolescent, and adult literatures and a concomitant study with college students. *J Learn Disabil* 40(1):49–65, 2007 17274547
- Froehlich TE, Lanphear BP, Epstein JN, et al: Prevalence, recognition, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in a national sample of US children. *Arch Pediatr Adolesc Med* 161(9):857–864, 2007 17768285

- Fuemmeler BF, Østbye T, Yang C, et al: Association between attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms and obesity and hypertension in early adulthood: a population-based study. *Int J Obes (Lond)* 35(6):852–862, 2011 20975727 10.1038/ijo.2010.214
- Gizer IR, Ficks C, Waldman ID: Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review. *Hum Genet* 126(1):51–90, 2009 19506906
- Kessler RC, Adler L, Barkley R, et al: The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. *Am J Psychiatry* 163(4):716–723, 2006 16585449
- Kieling C, Kieling RR, Rohde LA, et al: The age of onset of attention deficit hyperactivity disorder. *Am J Psychiatry* 167(1):14–16, 2010 20068122
- Klein RG, Mannuzza S, Olazagasti MA, et al: Clinical and functional outcome of childhood ADHD 33 years later. *Arch Gen Psychiatry*, October 15 2012 (Epub ahead of print) 23070149 10.1001/archgenpsychiatry.2012.271
- Mann EM, Ikeda Y, Mueller CW, et al: Cross-cultural differences in rating hyperactive-disruptive behaviors in children. *Am J Psychiatry* 149(11):1539–1542, 1992 1415822
- Mannuzza S, Klein RG, Bessler A, et al: Adult psychiatric status of hyperactive boys grown up. *Am J Psychiatry* 155(4):493–498, 1998 9545994
- Mannuzza S, Klein RG, Klein DF, et al: Accuracy of adult recall of childhood attention deficit hyperactivity disorder. *Am J Psychiatry* 159(11):1882–1888, 2002 12411223
- Merrill RM, Lyon JL, Baker RK, Gren LH: Attention deficit hyperactivity disorder and increased risk of injury. *Adv Med Sci* 54(1):20–26, 2009 19586835
- Miller TW, Nigg JT, Miller RL: Attention deficit hyperactivity disorder in African American children: what can be concluded from the past ten years ? *Clin Psychol Rev* 29(1):77–86, 2009 19008029
- Nigg JT, Lewis K, Edinger T, Falk M: Meta-analysis of attention-deficit/hyperactivity disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms, restriction diet, and synthetic food color additives. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 51(1):86–97, 2012 22176942
- Pastor PN, Reuben CA: Identified attention-deficit/hyperactivity disorder and medically attended, nonfatal injuries: US school-age children. 1997–2002. *Ambul Pediatr* 6(1):38–44, 2006 16443182
- Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, et al: The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and meta-regression analysis. *Am J Psychiatry* 164(6):942–948, 2007 17541055
- Shaw P, Eckstrand K, Sharp W, et al: Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 104(49):19649–19654, 2007 18024590
- Simon V, Czobor P, Bálint S, et al: Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis. *Br J Psychiatry* 194(3):204–211, 2009 19252145
- Stawicki JA, Nigg JT, von Eye A: Family psychiatric history evidence on the nosological relations of DSM-IV ADHD combined and inattentive subtypes: new data and meta-analysis. *J Child Psychol Psychiatry* 47(9):935–945, 2006 16930388
- Stevens LJ, Kuczek T, Burgess JR, et al: Dietary sensitivities and ADHD symptoms: thirty-five years of research. *Clin Pediatr (Phila)* 50(4):279–293, 2011 21127082
- Thapar A, Rice F, Hay D, et al: Prenatal smoking might not cause attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a novel design. *Biol Psychiatry* 66(8):722–727, 2009 19596120
- Turgay A, Goodman DW, Asherson P, et al: Lifespan persistence of ADHD: the life transition model and its applications. *J Clin Psychiatry* 73(2):192–201, 2012 22313720
- Willcutt EG, Nigg JT, Pennington BF, et al: Meta-analysis of DSM-IV attention-deficit/hyperactivity disorder dimensions and subtypes. *J. Abnorm Psychol* 121(4):991–1010, 2012 22612200 10.1037/a0027347

Trouble spécifique des apprentissages

- Aarnoudse-Moens CS, Weisglas-Kuperus N, van Goudoever JB, Oosterlaan J: Meta-analysis of neuro-behavioral outcomes in very preterm and/or very low birth weight children. *Pediatrics* 124(2):717–728, 2009 19651588
- Altarc M, Saroha E: Lifetime prevalence of learning disability among US children. *Pediatrics* 119(suppl 1):S77–83, 2007 17272589
- Barbaresi WJ, Katusic SK, Colligan RC, et al: Math learning disorder: incidence in a populationbased birth cohort, 1976–82, Rochester. Minn. *Ambul Pediatr* 5(5):281–289, 2005 16167851
- Breslau J, Miller E, Breslau N, et al: The impact of early behavior disturbances on academic achievement in high school. *Pediatrics* 123(6):1472–1476, 2009 19482756

- Butterworth B, Varma S, Laurillard D: Dyscalculia: from brain to education. *Science* 332(6033):1049–1053, 2011 21617068
- Daniel SS, Walsh AK, Goldston DB, et al: Suicidality, school dropout, and reading problems among adolescents. *J Learn Disabil* 39(6):507–514, 2006 17165618
- Geary DC: Consequences, characteristics, and causes of mathematical learning disabilities and persistent low achievement in mathematics. *J Dev Behav Pediatr* 32(3):250–263, 2011 21285895
- Gerber PJ: The impact of learning disabilities on adulthood: a review of the evidenced-based literature for research and practice in adult education. *J Learn Disabil* 45(1):31–46, 2012 22064950 10.1177/00222194114266858
- Goswami U, Wang HL, Cruz A, et al: Language-universal sensory deficits in developmental dyslexia: English, Spanish, and Chinese. *J Cogn Neurosci* 23(2):325–337, 2011 20146613
- Haworth CM, Kovas Y, Harlaar N, et al: Generalist genes and learning disabilities: a multivariate genetic analysis of low performance in reading, mathematics, language and general cognitive ability in a sample of 8000 12-year-old twins. *J Child Psychol Psychiatry* 50(10):1318–1325, 2009 19573035
- Katusic SK, Colligan RC, Weaver AL, Barbaresi WJ: The forgotten learning disability: epidemiology of written-language disorder in a population-based birth cohort (1976–1982), Rochester, Minnesota. *Pediatrics* 123(5):1306–1313, 2009 19403496
- Klassen R, Tze V, Hannok W: Internalizing problems of adults with learning disabilities: a meta-analysis. *J Learn Disabil* October 4, 2011 (Epub ahead of print) 22043025
- Landerl K, Moll K: Comorbidity of learning disorders: prevalence and familial transmission. *J Child Psychol Psychiatry* 51(3):287–294, 2010 19788550
- Lyytinen H, Aro M, Eklund K, et al: The development of children at familial risk for dyslexia: birth to early school age. *Ann Dyslexia* 54(2):184–220, 2004 15741935
- Maughan B, Messer J, Collishaw S, et al: Persistence of literacy problems: spelling in adolescence and at mid-life. *J Child Psychol Psychiatry* 50(8):893–901, 2009 19490310
- Mugnaini D, Lassi S, La Malfa G, Albertini G: Internalizing correlates of dyslexia. *World J Pediatr* 5(4):255–264, 2009 19911139
- National Joint Committee on Learning Disabilities: Learning disabilities: implications for policy regarding research and practice. LD Online, March 2011. Available at: <http://www.ldonline.org/pdfs/njcd/OverviewofLDValidityReport.pdf>. Accessed January 25, 2012.
- Nelson JM, Harwood H: Learning disabilities and anxiety: a meta analysis. *J Learn Disabil* 44(1):3–17, 2011 20375288
- Peterson RL, Pennington BF: Developmental dyslexia. *Lancet* 379(9830):1997–2007, 2012 22513218
- Piper BJ, Gray HM, Birkett MA: Maternal smoking cessation and reduced academic and behavioral problems in offspring. *Drug Alcohol Depend* 121(1–2):62–67, 2012 21937170
- Rabiner DL, Malone PS: Conduct Problems Prevention Research Group: The impact of tutoring on early reading achievement for children with and without attention problems. *J Abnorm Child Psychol* 32(3):273–284, 2004 15228176
- Reigosa-Crespo V, Valdes-Sosa M, Butterworth B, et al: Basic numerical capacities and prevalence of developmental dyslexia: The Havana Survey. *Dev Psychol* 48(1):123–135, 2012 21910533
- Rutter M, Caspi A, Fergusson D, et al: Sex differences in developmental reading disability: new findings from 4 epidemiological studies. *JAMA* 291(16):2007–2012, 2004 15113820
- Sexton CC, Gelhorn H, Bell JA, Classi PM: The co-occurrence of reading disorder and ADHD: epidemiology, treatment, psychosocial impact, and economic burden. *J Learn Disabil* 45(6):538–564, 2012 21757683 10.1177/0022219411407772
- Shalev RS, Manor O, Kerem B, et al: Developmental dyscalculia is a familial learning disability. *J Learn Disabil* 34(1):59–65, 2001 15497272
- Shaywitz SE, Shaywitz BA: Paying attention to reading: the neurobiology of reading and dyslexia. *Dev Psychopathol* 20(4):1329–1349, 2008 18838044
- Snowling MJ, Muter V, Carroll J: Children at family risk of dyslexia: a follow-up in early adolescence. *J Child Psychol Psychiatry* 48(6):609–618, 2007 17537077
- Svetaz MV, Ireland M, Blum R: Adolescents with learning disabilities: risk and protective factors associated with emotional well-being: findings from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. *J Adolesc Health* 27(5):340–348, 2000 11044706
- Torppa M, Eklund K, van Bergen E, Lyytinen H: Parental literacy predicts children's literacy: a longitudinal family-risk study. *Dyslexia* 17(4):339–355, 2011 22025422 10.1002/dys.437
- Willcutt EG, Pennington BF, Duncan L, et al: Understanding the complex etiologies of developmental disorders: behavioral and molecular genetic approaches. *J Dev Behav Pediatr* 31(7):533–544, 2010 20814254

Trouble développemental de la coordination

- Cairney J, Veldhuizen S, Szatmari P: Motor coordination and emotional-behavioral problems in children. *Curr Opin Psychiatry* 23(4):324–329, 2010 20520549
- Cantell MH, Smyth MM, Ahonen TP: Two distinct pathways for developmental coordination disorder: persistence and resolution. *Hum Mov Sci* 22(4–5):413–431, 2003 14624826
- Kadesjö B, Gillberg C: Developmental coordination disorder in Swedish 7-year-old children. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 38(7):820–828, 1999 10405499
- Lingam R, Hunt L, Golding J, et al: Prevalence of developmental coordination disorder using the DSM-IV at 7 years of age: a UK population-based study. *Pediatrics* 123(4):e693–e700, 2009 19336359
- Lingam R, Golding J, Jongmans MJ, et al: The association between developmental coordination disorder and other developmental traits. *Pediatrics* 126(5):e1109–e1118, 2010 20956425
- Martin NC, Piek J, Baynam G, et al: An examination of the relationship between movement problems and four common developmental disorders. *Hum Mov Sci* 29(5):799–808, 2010 19944472
- Rasmussen P, Gillberg C: Natural outcome of ADHD with developmental coordination disorder at age 22 years: a controlled, longitudinal, community-based study. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 39(11):1424–1431, 2000 11068898
- Sanger TD, Chen D, Delgado MR, et al: Definition and classification of negative motor signs in childhood. *Pediatrics* 118(5):2159–2167, 2006 17079590
- Wilson PH, McKenzie BE: Information processing deficits associated with developmental coordination disorder: a meta-analysis of research findings. *J Child Psychol Psychiatry* 39(6):829–840, 1998 9758192
- Zwicker JG, Missiuna C, Boyd LA: Neural correlates of developmental coordination disorder: a review of hypotheses. *J Child Neurol* 24(1):1273–1281, 2009 19687388

Mouvements stéréotypés

- Arron K, Oliver C, Moss J, et al: The prevalence and phenomenology of self-injurious and aggressive behaviour in genetic syndromes. *J Intellect Disabil Res* 55(2):109–120, 2011 20977515
- Berkson G, Tupa M, Sherman L: Early development of stereotyped and self-injurious behaviors, I: incidence. *Am J Ment Retard* 106(6):539–547, 2001 11708939
- Courtemanche A, Schroeder S, Sheldon J, et al: Observing signs of pain in relation to self-injurious behaviour among individuals with intellectual and developmental disabilities. *J Intellect Disabil Res* 56(5):501–515, 2012 21954901
- de Winter CF, Jansen AA, Evenhuis HM: Physical conditions and challenging behaviour in people with intellectual disability: a systematic review. *J Intellect Disabil Res* 55(7):675–698, 2011 21366751
- Harris JC: Advances in understanding behavioral phenotypes in neurogenetic syndromes. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 154C(4):389–399, 2010 20981768
- Harris KM, Mahone EM, Singer HS: Nonautistic motor stereotypies: clinical features and longitudinal follow-up. *Pediatr Neurol* 38(4):267–272, 2008 18358406
- Oliver C, Petty J, Ruddick L, Bacarese-Hamilton M: The association between repetitive, self-injurious and aggressive behavior in children with severe intellectual disability. *J Autism Dev Disord* 42(6):910–919, 2012 21720724
- Richards C, Oliver C, Nelson L, Moss J: Self-injurious behaviour in individuals with autism spectrum disorder and intellectual disability. *J Intellect Disabil Res* 56(5):476–489, 2012 22404122
- Singer HS: Stereotypic movement disorders. *Handb Clin Neurol* 100:631–639, 2011 21496612
- Sterling L, McGlaughlin A, King BH: Stereotypy and self-injury, in *Autism Spectrum Disorders*. Edited by Amaral D, Geschwind D, Dawson G. New York, Oxford University Press, 2011, pp 339–354.

Tics

- Bloch MH, Leckman JF: Clinical course of Tourette syndrome. *J Psychosom Res* 67(6):497–501, 2009 36541991
- Bloch M, State M, Pittenger C: Recent advances in Tourette syndrome. *Curr Opin Neurol* 24(2):119–125, 2011 21386676
- Centers for Disease Control, Prevention: Prevalence of diagnosed Tourette syndrome in persons aged 6–17 years—United States. 2007. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 58(21):581–585, 2009 19498335

- Conelea CA, Woods DW, Zinner SH, et al: Exploring the impact of chronic tic disorders on youth: results from the Tourette Syndrome Impact Survey. *Child Psychiatry Hum Dev* 42(2):219–242, 2011a 21046225
- Conelea CA, Woods DW, Zinner SH, et al: The impact of Tourette syndrome in adults: results from the Tourette Syndrome Impact Survey. *Community Ment Health J*, November 4 2011b (Epub ahead of print) 22052430
- Fernandez TV, Sanders SJ, Yurkiewicz IR, et al: Rare copy number variants in Tourette syndrome disrupt genes in histaminergic pathways and overlap with autism. *Biol Psychiatry* 71(5):392–402, 2012 22169095 10.1016/j.biopsych.2011.09.034
- Hassan N, Cavanna AE: The prognosis of Tourette syndrome: implications for clinical practice. *Funct Neurol* 27(1):23–27, 2012 22687163
- Jankovic J, Gelineau-Kattner R, Davidson A: Tourette's syndrome in adults. *Mov Disord* 25(13):2171–2175, 2010 20690167
- Knight T, Steeves T, Day L, et al: Prevalence of tic disorders: a systematic review and meta-analysis. *Pediatr Neurol* 47(2):77–90, 2012 22759682
- Leckman JF, Walker DE, Cohen DJ: Premonitory urges in Tourette's syndrome. *Am J Psychiatry* 150(1):98–102, 1993 8417589
- Lehman LL, Gilbert DL, Leach JL, et al: Vertebral artery dissection leading to stroke caused by violent neck tics of Tourette syndrome. *Neurology* 77(18):1706–1708, 2011 21975212
- Lewin AB, Murphy TK, Storch EA, et al: A phenomenological investigation of women with Tourette or other chronic tic disorders. *Compr Psychiatry* 53(5):525–534, 2012 21867997 10.1016/j.comppsy.2011.07.004
- Mathews CA, Bimson B, Lowe TL, et al: Association between maternal smoking and increased symptom severity in Tourette's syndrome. *Am J Psychiatry* 163(6):1066–1073, 2006 16741208
- Olfson M, Crystal S, Gerhard T, et al: Patterns and correlates of tic disorder diagnoses in privately and publicly insured youth. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 50(2):119–131, 2011 21241949 10.1016/j.jaac.2010.11.009
- O'Roak BJ, Morgan TM, Fishman DO, et al: Additional support for the association of SLITRK1 var321 and Tourette syndrome (letter). *Mol Psychiatry* 15(5):447–450, 2010 20351724 10.1038/mp.2009.105
- O'Rourke JA, Scharf JM, Yu D, Pauls DL: The genetics of Tourette syndrome: a review. *J Psychosom Res* 67(6):533–545, 2009 19913658 10.1016/j.jpsychores.2009.06.006
- Sanger TD, Chen D, Fehlings DL, et al: Definition and classification of hyperkinetic movements in childhood. *Mov Disord* 25(11):1538–1549, 2010 20589866
- Singer HS: Tourette syndrome and other tic disorders. *Handb Clin Neurol* 100:641–657, 2011 21496613
- Stein DJ, Grant JE, Franklin ME, et al: Trichotillomania (hair pulling disorder), skin picking disorder, and stereotypic movement disorder: toward DSM-V. *Depress Anxiety* 27(6):611–626, 2010 20533371

Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques

Le spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques comprend la schizophrénie, les autres troubles psychotiques et la personnalité schizotypique. Ces troubles sont définis par des anomalies dans au moins un des cinq domaines suivants : idées délirantes, hallucinations, pensée désorganisée (discours), comportement moteur grossièrement désorganisé ou anormal (incluant la catatonie) et symptômes négatifs.

Éléments clés qui définissent les troubles psychotiques

Idées délirantes

Les *idées délirantes* sont des croyances figées qui ne changent pas face à des évidences qui les contredisent. Leur contenu peut comprendre divers thèmes (p. ex. thème de persécution, thème de référence, thème somatique, thème religieux, thème mégalomaniac). Les *idées délirantes de persécution* (c.-à-d. la croyance que l'on peut être agressé, harcelé, etc. par un individu, une organisation ou d'autres groupes) sont les plus fréquentes. Les *idées délirantes de référence* (c.-à-d. la croyance que certains gestes, commentaires ou éléments de l'environnement, etc. sont destinés spécifiquement à la personne) sont aussi assez fréquentes. Les *idées délirantes mégalomaniacques* (c.-à-d. quand une personne croit à tort qu'elle a des capacités, une richesse ou une renommée exceptionnelles) ou les *idées délirantes érotomaniacques* (c.-à-d. quand une personne croit à tort qu'une autre personne l'aime) sont aussi rencontrées. Les *idées délirantes à thème de nihilisme* sont la conviction qu'une catastrophe majeure va survenir, et les *idées délirantes à thème somatique* sont centrées sur des préoccupations concernant la santé ou le fonctionnement des organes.

Les idées délirantes sont considérées comme *bizarres* si elles sont clairement invraisemblables et incompréhensibles pour des personnes d'une même culture et qu'elles ne proviennent pas d'expériences ordinaires de la vie. Un exemple d'idée délirante bizarre est la croyance qu'un étranger a enlevé les organes internes du sujet et les a remplacés par ceux de quelqu'un d'autre sans laisser de plaies ou de cicatrices. Un exemple d'idée délirante non bizarre est la conviction d'être sous surveillance policière en dépit d'une absence de preuves convaincantes. Les idées délirantes qui expriment une perte de contrôle sur l'esprit ou le corps sont généralement considérées comme bizarres ; elles incluent la croyance que les pensées du sujet ont été retirées par une force extérieure quelconque (*vol de la pensée*), que des pensées étrangères ont été placées dans son esprit (*pensées imposées*) ou que son corps ou ses actes sont agis ou manipulés par une force extérieure quelconque (*syndrome d'influence*). Il est parfois difficile de faire la distinction entre une idée délirante et une croyance fortement ancrée ; cette distinction dépend en partie du degré de conviction avec lequel la croyance est soutenue en dépit de preuves contraires claires et rationnelles à propos de sa véracité.

Hallucinations

Les *hallucinations* sont des expériences de type perceptif qui surviennent sans stimulus externe. Elles sont saisissantes et claires, avec la force et l'impact des perceptions

normales, et elles ne sont pas sous le contrôle de la volonté. Elles peuvent concerner toutes les modalités sensorielles mais les hallucinations auditives sont les plus fréquentes dans la schizophrénie et les troubles apparentés. Les hallucinations auditives sont éprouvées généralement comme des voix familières ou étrangères, qui sont perçues comme distinctes des propres pensées du sujet. Les hallucinations doivent survenir dans le contexte d'une conscience claire ; celles qui apparaissent pendant l'endormissement (*hypnagogiques*) ou au réveil (*hypnopompiques*) sont considérées comme faisant partie de la gamme des expériences normales. Des hallucinations peuvent faire partie d'une expérience religieuse normale dans certains contextes culturels.

Pensée désorganisée (discours)

La *pensée désorganisée (trouble du cours de la pensée)* est typiquement déduite du discours de l'individu. Ce dernier peut passer ainsi d'un sujet à l'autre (*déraillement ou relâchement des associations*). Les réponses peuvent être reliées de manière indirecte aux questions ou ne pas y être reliées du tout (*pensée tangentielle*). Plus rarement, le discours peut être si gravement désorganisé qu'il est pratiquement incompréhensible et ressemble à une aphasie réceptive par sa désorganisation linguistique (*incohérence* ou « salade de mots »). Du fait qu'il est courant et non spécifique de rencontrer un discours légèrement désorganisé, le symptôme doit être suffisamment important pour altérer de manière substantielle l'efficacité de la communication. La sévérité de cette altération peut être difficile à évaluer si la personne qui fait le diagnostic a un bagage linguistique différent de celui de la personne évaluée. Une pensée ou un discours moins sévèrement désorganisés peuvent se rencontrer au cours des périodes prodromiques et résiduelles de la schizophrénie.

Comportement moteur anormal ou grossièrement désorganisé (incluant la catatonie)

Le *comportement moteur anormal ou grossièrement désorganisé* peut se manifester de diverses manières, allant de la niaiserie puérile à une agitation imprévisible. Des problèmes peuvent être relevés dans toute forme de comportement dirigé vers un but, conduisant à des difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne.

Le *comportement catatonique* correspond à une réactivité à l'environnement très diminuée. Cela va de la résistance aux instructions (*néguativisme*) au maintien d'une posture rigide, inappropriée ou bizarre et à l'absence totale de réponse verbale ou motrice (*mutisme* ou *stupeur*). Cela peut aussi inclure une activité motrice sans but et excessive sans cause évidente (*agitation catatonique*). D'autres caractéristiques sont constituées par des mouvements stéréotypés, la fixité du regard, les grimacements, le mutisme et l'écholalie. Bien que la catatonie ait été historiquement associée à la schizophrénie, les symptômes catatoniques ne sont pas spécifiques et peuvent survenir dans d'autres troubles (p. ex. troubles dépressifs ou bipolaires avec catatonie) et dans diverses affections médicales (trouble catatonique dû à une autre affection médicale).

Symptômes négatifs

Les *symptômes négatifs* comptent pour une grande part dans la morbidité associée à la schizophrénie mais ils sont moins prééminents dans les autres troubles psychotiques. Deux symptômes négatifs sont particulièrement prééminents dans la schizophrénie : la diminution de l'expression émotionnelle et l'aboulie. La *diminution de l'expression émotionnelle* comprend la réduction de l'expression émotionnelle du visage, du contact visuel, de l'intonation du discours (prosodie) et des mouvements des mains, de la tête et du visage qui transmettent les accents émotionnels du discours. L'*aboulie* se manifeste

par une diminution de la motivation pour des activités auto-initiées et dirigées vers un but. L'individu peut rester assis pendant de longues périodes de temps et montrer peu d'intérêt pour la participation aux activités professionnelles ou sociales. Les autres symptômes négatifs comprennent l'alogie, l'anhédonie et l'asociabilité. *L'alogie* se manifeste par une diminution de la production du discours. *L'anhédonie* est une diminution des capacités à éprouver du plaisir à partir de stimuli positifs ou à se rappeler de plaisirs antérieurement éprouvés (Kring et Moran 2008). *L'asociabilité* fait référence au manque d'intérêt pour les interactions sociales et peut être associée à l'aboulie mais peut aussi être une manifestation d'une diminution des opportunités d'interactions sociales.

Les troubles de ce chapitre

Ce chapitre est organisé selon un gradient psychopathologique. Les cliniciens doivent d'abord considérer les situations qui ne répondent pas à l'ensemble des critères d'un trouble psychotique ou qui sont limités à un domaine de psychopathologie. Ensuite ils doivent considérer les situations qui portent sur des périodes de temps restreintes. Enfin, le diagnostic de trouble du spectre de la schizophrénie exige l'exclusion des autres affections qui peuvent engendrer un trouble psychotique.

La personnalité schizotypique est mentionnée dans ce chapitre du fait qu'elle est considérée comme faisant partie intégrante du spectre de la schizophrénie, bien que sa description complète figure dans le chapitre « Troubles de la personnalité ». Le diagnostic de personnalité schizotypique comprend un ensemble étendu de déficits sociaux et interpersonnels incluant une réduction des capacités à établir des relations interpersonnelles proches, des distorsions cognitives et perceptuelles, des comportements excentriques qui apparaissent généralement au début de la vie adulte mais qui peuvent parfois déjà être observés durant l'enfance ou l'adolescence. Le niveau d'anormalité des croyances, des pensées ou des perceptions est sous le seuil exigé pour le diagnostic de trouble psychotique.

Deux affections sont définies par des anomalies limitées à un domaine de la psychose : le trouble délirant et la catatonie. Le trouble délirant est caractérisé par la persistance d'idées délirantes pendant au moins un mois, sans autre symptôme psychotique. La catatonie est décrite plus loin dans ce chapitre et abordée ultérieurement dans la discussion.

Le trouble psychotique bref dure plus d'un jour et se résout en moins d'un mois. Le trouble schizophréniforme est caractérisé par une présentation équivalente à celle de la schizophrénie sauf pour la durée (moins de 6 mois) et pour la dégradation du fonctionnement qui n'est pas requise.

La schizophrénie dure au moins 6 mois et comprend au moins un mois où sont présents les symptômes de la phase active. Dans le trouble schizoaffectif, un épisode thymique et les symptômes de la phase active de la schizophrénie sont présents de façon simultanée et sont précédés ou suivis par au moins 2 semaines pendant lesquelles des hallucinations ou des idées délirantes sont présentes sans symptômes thymiques prééminents.

Les troubles psychotiques peuvent aussi être induits par d'autres affections. Dans le trouble psychotique induit par une substance/un médicament, les symptômes psychotiques sont interprétés comme la conséquence physiologique de l'utilisation d'une substance donnant lieu à abus, d'un médicament ou d'un composé toxique et cessent après l'élimination de l'agent chimique. Dans le trouble psychotique dû à une autre affection médicale, les symptômes psychotiques sont interprétés comme la conséquence physiologique directe d'une autre pathologie médicale.

La catatonie peut survenir dans de nombreux troubles, comprenant les troubles développementaux, psychotiques, bipolaires, dépressifs et d'autres troubles mentaux.

Ce chapitre inclut aussi les diagnostics de catatonie associée à un autre trouble mental (spécification de la catatonie), de catatonie due à une autre affection médicale ou de catatonie non spécifiée et les critères diagnostiques de ces trois formes sont décrits ensemble.

D'autres troubles psychotiques et d'autres troubles du spectre de la schizophrénie, spécifiés ou non spécifiés sont inclus pour classer les formes cliniques qui ne réunissent les critères d'aucun trouble psychotique spécifique ou pour classer une symptomatologie psychotique pour laquelle les informations sont inadéquates ou contradictoires.

Évaluation par le clinicien des symptômes et des phénomènes cliniques reliés à la psychose

Les troubles psychotiques sont hétérogènes et la sévérité des symptômes peut prédire d'importants aspects de la maladie, comme le degré de déficit cognitif ou neurobiologique (Barch et al. 2003). Pour progresser, un cadre de travail détaillé d'évaluation de la sévérité est inclus dans la section III « Mesures d'évaluation » et peut aider à la planification thérapeutique, aux décisions liées au pronostic et à la recherche sur les mécanismes neurophysiologiques. La section III « Mesures d'évaluation » contient aussi les évaluations dimensionnelles des symptômes primaires, comme les hallucinations, les idées délirantes, le discours désorganisé (excepté pour les troubles psychotiques induits par des substances/médicaments et les troubles psychotiques dus à une autre affection médicale), le comportement psychomoteur anormal, les symptômes négatifs et l'évaluation dimensionnelle de la dépression et de la manie. La sévérité des symptômes thymiques dans les troubles psychotiques a une valeur pronostique et guide le traitement (Peralta et Cuesta 2009). Il existe des preuves de plus en plus importantes pour estimer que le trouble schizoaffectif n'est pas une catégorie nosologique distincte (e.g., Owen et al. 2007). Ainsi l'évaluation dimensionnelle de la dépression et de la manie pour tous les troubles psychotiques sensibilise le clinicien à la composante thymique et à la nécessité de la traiter de façon appropriée. L'échelle de la section III comprend également une évaluation dimensionnelle des déficits cognitifs. De nombreuses personnes ayant un trouble psychotique présentent des déficits dans une gamme de domaines cognitifs (Reichenberg et al. 2009) qui prédisent le statut fonctionnel (Green et al. 2004). Une évaluation clinique neuropsychologique peut aider à guider le diagnostic et le traitement. Cependant, des évaluations brèves, sans évaluation neuropsychologique formelle peuvent fournir une information (Gold et al. 1999 ; Hurford et al. 2011 ; Keefe et al. 2004) parfois suffisante par rapport aux objectifs du diagnostic. Les tests neuropsychologiques formels, quand ils sont réalisés, doivent être mis en œuvre par du personnel entraîné à l'utilisation de ces outils psychométriques. Si aucune évaluation neuropsychologique formelle n'est réalisée, le clinicien doit utiliser les informations disponibles les plus adaptées pour étayer son jugement. Des recherches complémentaires sur ces évaluations sont nécessaires pour déterminer leur utilité clinique. Aussi les évaluations de la section III doivent servir de prototype pour stimuler une telle recherche.

Personnalité schizotypique

Les critères et le texte pour la personnalité schizotypique se trouvent dans le chapitre « Troubles de la personnalité ». Comme ce trouble est considéré comme faisant partie du spectre de la schizophrénie et qu'il est étiqueté comme trouble schizotypique dans cette section de la CIM-9 et de la CIM-10, il est mentionné dans ce présent chapitre du DSM-5 mais il est discuté plus en détail dans le chapitre « Troubles de la personnalité ».

Trouble délirant

Critères diagnostiques

297.1 (F22)

- A. Présence d'une (ou de plusieurs) idées délirantes pendant une durée de 1 mois ou plus.
- B. Le critère A de la schizophrénie n'a jamais été rempli.
N.B. : Si des hallucinations sont présentes, elles ne sont pas prééminentes et elles sont en rapport avec le thème du délire (p. ex. la sensation d'être infesté par des insectes associée à des idées délirantes d'infestation).
- C. En dehors de l'impact de l'idée (des idées) délirante(s) ou de ses (leurs) ramifications, il n'y a pas d'altération marquée du fonctionnement ni de singularités ou de bizarreries manifestes du comportement.
- D. Si des épisodes maniaques ou dépressifs caractérisés sont survenus concomitamment, ils ont été de durée brève comparativement à la durée globale de la période délirante.
- E. La perturbation n'est pas due aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale et elle n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental comme l'obsession d'une dysmorphie corporelle ou un trouble obsessionnel-compulsif.

Spécifier le type :

Type érotomane : Ce sous-type s'applique quand le thème central des idées délirantes est qu'une personne est amoureuse du sujet.

Type mégalomane : Ce sous-type s'applique quand le thème central des idées délirantes est la conviction d'avoir un grand talent (mais non reconnu), ou une compréhension profonde des choses ou d'avoir fait des découvertes importantes.

Type de jalousie : Ce sous-type s'applique quand le thème central des idées délirantes de la personne est que le conjoint ou l'être aimé est infidèle.

Type de persécution : Ce sous-type s'applique quand le thème central des idées délirantes consiste en la croyance d'être la cible d'un complot, d'une escroquerie, d'espionnage, d'une filature, d'un empoisonnement, de harcèlement, de calomnies ou d'une obstruction à la poursuite de ses projets à long terme.

Type somatique : Ce sous-type s'applique quand le thème central des idées délirantes concerne des fonctions ou des sensations corporelles.

Type mixte : Ce sous-type s'applique quand aucun thème délirant ne prédomine.

Type non spécifié : Ce sous-type s'applique quand la croyance délirante dominante ne peut pas être clairement identifiée ou quand elle n'est pas décrite dans un des sous-types spécifiques (p. ex. idées délirantes de référence sans persécution prédominante ni idée mégalomane).

Spécifier si :

Avec contenu bizarre : Les idées délirantes sont jugées bizarres si elles sont clairement invraisemblables, non compréhensibles et si elles ne dérivent pas d'expériences de la vie ordinaire (p. ex. croyance qu'un inconnu lui a enlevé des organes internes et les a remplacés par les organes d'autres personnes sans avoir laissé aucune blessure ou cicatrice).

Spécifier si :

Les spécifications suivantes de l'évolution ne peuvent s'appliquer que si au moins une année s'est écoulée depuis la survenue initiale du trouble :

Premier épisode, actuellement en épisode aigu : Première manifestation du trouble remplissant les critères diagnostiques de définition et les critères de durée. Un *épisode aigu* est une période de temps durant laquelle les critères symptomatiques sont remplis.

Premier épisode, actuellement en rémission partielle : Une *rémission partielle* est une période de temps durant laquelle une amélioration après un épisode antérieur se maintient et où les critères diagnostiques du trouble ne sont que partiellement remplis.

Premier épisode, actuellement en rémission complète : Une *rémission complète* est une période de temps après un épisode antérieur durant laquelle aucun symptôme spécifique du trouble n'est présent.

Multiples épisodes, actuellement en épisode aigu

Multiples épisodes, actuellement en rémission partielle

Multiples épisodes, actuellement en rémission complète

Continu : Les symptômes remplissant les critères symptomatiques diagnostiques du trouble sont présents la majorité du temps de la maladie, les périodes de symptômes subliminaux étant très brèves au regard de l'ensemble de l'évolution.

Non spécifié

Spécifier la sévérité actuelle :

La sévérité est cotée par une évaluation quantitative des symptômes psychotiques primaires, dont les idées délirantes, les hallucinations, la désorganisation du discours, les comportements psychomoteurs anormaux et les symptômes négatifs. Chacun de ces symptômes peut être coté pour sa sévérité actuelle (en prenant en compte l'intensité la plus sévère au cours des 7 derniers jours) sur une échelle de 5 points, allant de 0 (absent) à 4 (présent et grave). (Cf. dans le chapitre « Mesures d'évaluation » l'évaluation dimensionnelle de la sévérité des symptômes psychotiques par le clinicien.)

N.B. : Un diagnostic de trouble délirant peut être posé sans utiliser cette spécification de la sévérité.

Sous-types

Dans le délire de *type érotomaniaque*, le thème délirant central est la conviction d'être aimé par une autre personne. La personne qui fait l'objet de cette conviction est habituellement d'un niveau social plus élevé que le sujet (p. ex. un personnage célèbre ou un supérieur hiérarchique) mais il peut s'agir d'une personne complètement étrangère au patient. Fréquemment le sujet s'efforce d'entrer en contact avec l'objet de son délire. Dans le délire de *type mégalomaniaque*, le thème délirant central est la conviction de posséder soit un don supérieur, soit une grande capacité de clairvoyance ou d'avoir fait une importante découverte. Moins couramment, le délire a pour thème l'existence d'une relation exceptionnelle avec une personne très en vue, ou l'identification à un personnage éminent (auquel cas ce personnage, s'il est en vie, est considéré comme un imposteur). Ces idées délirantes mégalomaniaques peuvent avoir un contenu religieux. Dans le délire à *type de jalousie*, le thème délirant central est la conviction que le partenaire est infidèle. Le sujet en vient à cette conclusion sans raison valable et il se fonde sur des déductions erronées appuyées sur des éléments mineurs servant de « preuves » (p. ex. des vêtements en désordre). Le sujet qui délire entre habituellement en conflit avec son conjoint ou son amant et entreprend des actions à propos de l'infidélité qu'il imagine. Dans le délire à *type de persécution*, le thème délirant central comporte la conviction que l'on complotte contre le sujet, qu'il est trompé, espionné, poursuivi, empoisonné ou drogué, diffamé avec méchanceté, harcelé ou entravé dans la poursuite de ses buts à long terme. Des problèmes mineurs peuvent être exagérés et former le noyau d'un système délirant. La personne atteinte peut entreprendre des démarches répétées pour obtenir satisfaction par des actions judiciaires ou légales. Les personnes présentant des idées délirantes de persécution éprouvent souvent du ressentiment et de la colère et peuvent recourir à la violence contre ceux qu'ils croient coupables de malveillance à leur égard. Dans le délire de *type somatique*, le thème délirant central implique des fonctions ou des sensations corporelles. Les idées délirantes somatiques se présentent sous plusieurs aspects. Elles concernent le plus souvent la croyance par le patient qu'il dégage une odeur nauséabonde, qu'il est infesté par des insectes qui sont sur ou sous la peau, qu'il

a un parasite à l'intérieur de son corps, que certaines parties de son corps sont laides ou difformes, que certaines parties de son corps ne fonctionnent pas.

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique principale du trouble délirant est la présence d'une ou plusieurs idées délirantes qui persistent pendant au moins un mois (critère A). On ne porte pas le diagnostic de trouble délirant si le sujet a déjà présenté un tableau symptomatique qui répond au critère A de la schizophrénie (critère B). Mis à part l'impact direct des idées délirantes, le fonctionnement psychosocial est altéré d'une façon moins marquée que dans les autres troubles psychotiques et le comportement n'est ni manifestement singulier ni bizarre (critère C). Si des épisodes thymiques surviennent en même temps que des idées délirantes, la durée totale de ces épisodes thymiques est relativement brève par rapport à la durée totale des périodes délirantes (critère D). Les idées délirantes ne sont pas dues aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. cocaïne) ou à une affection médicale (p. ex. maladie d'Alzheimer) et ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental comme l'obsession d'une dysmorphie corporelle ou un trouble obsessionnel-compulsif (critère E).

En plus des cinq domaines symptomatiques identifiés dans les critères diagnostiques, l'évaluation des symptômes dans les domaines de la cognition, de la dépression et de la manie est fondamentale pour faire des distinctions d'importance cruciale entre les différents troubles du spectre de la schizophrénie et les autres troubles psychotiques.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Des problèmes sociaux, conjugaux ou professionnels peuvent résulter des convictions délirantes du trouble délirant (de Portugal et al. 2011 ; Kendler 1982 ; Kendler et Walsh 1995 ; Marneros et al. 2012). Les personnes présentant un trouble délirant peuvent être capables de décrire factuellement que les autres considèrent leurs croyances comme irrationnelles mais sont elles-mêmes incapables de les admettre comme telles (c.-à-d. qu'elles peuvent avoir un « *insight* factuel » mais pas un véritable *insight*). De nombreux individus développent une humeur dysphorique ou irritable, ce qui peut être habituellement interprété comme une réaction à leurs croyances délirantes (de Portugal et al. 2008). Des colères marquées et des comportements violents peuvent se produire, tout particulièrement dans les formes à type de persécution, à type de jalousie et à type érotomaniaque. Le sujet peut adopter un comportement procédurier ou quérulent (p. ex. en envoyant des centaines de lettres de réclamation aux autorités gouvernementales). Des problèmes juridiques peuvent survenir dans le trouble délirant à type de jalousie ou à type érotomaniaque.

Prévalence

La prévalence sur la vie du trouble délirant a été estimée à 0,2 % (Perälä et al. 2007). Le sous-type le plus fréquent est le délire de persécution (de Portugal et al. 2010). Le trouble délirant à type de jalousie est probablement plus fréquent chez l'homme que chez la femme mais il n'y a pas globalement de différence majeure de fréquence pour le trouble délirant entre hommes et femmes (de Portugal et al. 2010 ; Kendler 1982 ; Marneros et al. 2012 ; Wustmann et al. 2011).

Développement et évolution

En moyenne l'évolution globale est généralement meilleure que celle observée dans la schizophrénie (de Portugal et al. 2008 ; de Portugal et al. 2010 ; de Portugal et al. 2011 ; Kendler 1982 ; Kendler et Walsh 1995 ; Marneros et al. 2012). Bien que le diagnostic soit généralement stable, une partie des individus finit par développer une schizophrénie (Marneros et al. 2012 ; Salvatore et al. 2011). On retrouve un lien familial significatif

entre le trouble délirant et à la fois la schizophrénie et la personnalité schizotypique (Kendler et al. 1993). Bien qu'ils puissent survenir chez des sujets jeunes, ces troubles ont une prévalence plus forte chez les personnes plus âgées (de Portugal et al. 2010 ; Kendler 1982 ; Marneros et al. 2012 ; Wustmann et al. 2011).

Questions diagnostiques liées à la culture

Le contexte culturel et religieux doit être pris en compte dans l'évaluation de l'existence possible d'un trouble délirant. Le contenu des idées délirantes peut varier également selon le contexte culturel.

Retentissement fonctionnel du trouble délirant

Les altérations du fonctionnement sont en général plus circonscrites que celles observées dans les autres troubles psychotiques, bien que dans certains cas ces altérations soient importantes et comprennent une pauvreté du fonctionnement professionnel et un isolement social (de Portugal et al. 2008 ; de Portugal et al. 2011 ; Kendler et Walsh 1995 ; Marneros et al. 2012). Quand le fonctionnement psychosocial est altéré, les croyances délirantes y contribuent souvent par elles-mêmes de façon significative. Une caractéristique fréquente des individus ayant un trouble délirant est celle de l'apparente normalité de leur comportement et de leur allure tant que les idées délirantes ne sont pas mises en question ou traduites en action.

Diagnostic différentiel

Troubles obsessionnel-compulsif et apparentés. Si un individu présentant un trouble obsessionnel-compulsif est complètement convaincu que ses croyances obsessionnelles-compulsives sont vraies, alors le diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif avec la spécification absence d'*insight*/croyances délirantes doit être posé de préférence à celui de trouble délirant. De même, si un individu présentant une obsession d'une dysmorphie corporelle est complètement convaincu que ses croyances dysmorphophobiques corporelles sont vraies, le diagnostic d'obsession d'une dysmorphie corporelle avec la spécification d'absence d'*insight*/croyances délirantes doit être porté de préférence à celui de trouble délirant.

État confusionnel, trouble neurocognitif majeur, trouble psychotique dû à une autre affection médicale et trouble psychotique induit par une substance/un médicament. Les individus ayant ces troubles peuvent présenter des symptômes qui suggèrent un trouble délirant. Par exemple, des idées délirantes simples de persécution dans le contexte de troubles neurocognitifs majeurs pourraient être diagnostiquées comme un trouble neurocognitif majeur avec perturbation du comportement. À un moment donné le trouble psychotique induit par une substance/un médicament peut avoir une symptomatologie identique à celle d'un trouble délirant mais peut en être distingué par la relation chronologique entre l'utilisation de la substance et le début et la disparition des croyances délirantes.

Schizophrénie et trouble schizophréniforme. Le trouble délirant peut être distingué de la schizophrénie et du trouble schizophréniforme par l'absence des autres symptômes caractéristiques de la phase active de la schizophrénie.

Troubles dépressifs et bipolaires et trouble schizoaffectif. Ces troubles peuvent être distingués du trouble délirant par la relation temporelle entre la perturbation de l'humeur et les idées délirantes et par la sévérité des symptômes thymiques. Si les idées délirantes surviennent exclusivement durant les épisodes thymiques, le diagnostic sera celui de trouble dépressif ou de trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques. Des symptômes thymiques qui correspondent entièrement aux critères d'un épisode